

Monotropismus und sein Geflecht an Komorbiditäten: Direkte und indirekte Verbindungen zu Verhaltens-, psychiatrischen und neuroentwicklungsbezogenen Zuständen

Ein zitiertes Forschungsdossier.

Zusammenfassung

Monotropismus (Murray, Lawson & Lesser, 2005) ist eine Theorie der autistischen Aufmerksamkeit, die Autismus als Unterschied in der *Ressourcenverteilung* fasst: Ein monotroner Geist konzentriert Verarbeitungsressourcen in eine kleine Zahl hoch erregter „Aufmerksamkeitstunnel“ und lässt weniger Ressourcen für periphere Kanäle. Ein Selbstbeurteilungsinstrument von 2023 – der **Monotropism Questionnaire (MQ)** – liefert die erste empirische Validierung und zeigt, dass autistische und ADHD-Menschen signifikant höher scoren als nicht-autistische/nicht-ADHD-Kontrollen [1][2][3]. Ein eng verwandtes begutachtetes Modell, Goldknopfs Ansatz der **atypischen Ressourcenverteilung**, argumentiert, dass dieselbe verschmälert-intensive Aufmerksamkeit die sensorischen, sozialen, exekutiven und motorischen Merkmale des Autismus verbinden kann – warnt aber, dass dies „höchstwahrscheinlich ein Faktor bei autistischen Menschen mit starken Sensorik-Symptomen“ ist, nicht die alleinige Ursache [4].

Weil Monotropismus eine Theorie darüber ist, *wie Ressourcen aufgewendet werden*, wirkt sie plausibel in viele Bereiche hinein. Das ehrliche Bild zerfällt jedoch in drei Ebenen:

- **Ebene 1 — Direkte, empirisch gestützte Verbindungen.** Die Autismus–ADHD–Überschneidung („AuDHD“) ist die stärkste: Der MQ zeigt, dass monotrope Aufmerksamkeit in *beiden* Bedingungen erhöht ist, und rahmt den „monotropen Split“ (konkurrierende oder instabile Tunnel) als reales, messbares Aufmerksamkeits-Phänotyp um [2][3][5]. Auf Mechanismusebene überlappen atypische **Interozeption** und **exekutive Dysfunktion** – gut belegt und helfen, nachgelagerte Probleme mit Essen, Vermüllung und Vermeidung zu erklären [6][7][8].
- **Ebene 2 — Indirekte, über gemeinsame Mechanismen vermittelte Komorbidität.** Autismus überschneidet sich deutlich mit **Anorexie/restriktivem Essen** und **OCD**. In jedem Fall ist die Komorbidität real und repliziert, aber die *am besten belegte* Brücke ist ein gemeinsamer Mechanismus (Interozeption; ego-syntone vs. ego-dystone Verarbeitung) statt Monotropismus spezifisch [6][9][10].
- **Ebene 3 — Plausible Extrapolation oder umstrittene Konstrukte.** Einige Verbindungen im populären Framing – „Doom-Stacks“ als monotropes Objektpermanenz-Versagen, Agoraphobie als primäres monotropes Ergebnis, **PDA** als eigenes Profil – beruhen auf schwächerer oder umstrittener Evidenz und sollten als Hypothesen, nicht als etablierte Fakten behandelt werden [11][12][13].

Durchgehend ein wiederkehrendes Thema: Viele Verhaltensweisen, die wie separate „Störungen“ wirken, lesen sich besser als **die kognitive Kosten eines engen Aufmerksamkeitssystems, das mit einer polytropen Welt kollidiert** – aber nur einige dieser Lesarten wurden direkt getestet.

1. Grundlagen: was Monotropismus ist und wie solide er ist

Monotropismus besagt, dass sich Geister darin unterscheiden, wie sie Aufmerksamkeitsressourcen verteilen. Ein **polytroper** Geist hält viele Interessenkanäle zugleich aktiv (breit, flach, leichter Wechsel); ein **monotroper** Geist leitet Ressourcen in wenige intensiv erregte „Aufmerksamkeitstunnel“ (eng, tief, schwer zu wechseln) [1][3]. Die Urheberinnen und Urheber – Dinah Murray, Wenn Lawson und Mike Lesser – stellten die Idee erstmals ab 1992 auf den Durham-Autismus-

Konferenzen vor und formalisierten sie 2005, mit dem Argument, sie erkläre autistische Züge (Spezialinteressen, Bedürfnis nach Gleichbleiben, Belastung bei Übergängen, Detailfokus) besser als rein defizitorientierte Modelle [1][14].

Ihr wissenschaftlicher Status hat sich in den letzten Jahren verschoben:

- Er ist **empirisch messbar**. Der MQ (Garau et al., 2023) ist ein 47-Item-Selbstbeurteilungsinstrument, getestet an 1.110 Teilnehmenden (756 autistisch, 354 nicht-autistisch). Autistische und ADHD-Teilnehmende scoren signifikant höher als Kontrollen [2][3].
- Er hat einen **begutachteten mechanistischen Vetter**. Goldknopfs Modell der „atypischen Ressourcenverteilung“ (*Frontiers in Integrative Neuroscience*, 2013) operationalisiert die Intuition: Bei Autismus sind Aufmerksamkeitsressourcen **vershmälert** (auf weniger/kleinere Areale, Modalitäten und Verarbeitungsstufen, teils intensiver) und/oder in der Gesamtkapazität **vermindert** – ein Rahmen, der Sprache, soziale Kognition, sensorische/aufmerksamkeitsbezogene Atypizität und exekutive/motorische Unterschiede ausdrücklich verbindet [4].
- Er steht **neben, nicht statt** anderer kognitiver Theorien (Theory of Mind; schwache zentrale Kohärenz / detailfokussierter Stil (Happé & Frith, 2006); exekutive Dysfunktion) [4][15].
- Er ist noch ein **Modell, kein Biomarker**. Goldknopf ist explizit, dass es ein Faktor unter mehreren ist, „höchstwahrscheinlich“ bedeutsam bei autistischen Menschen mit starken Sensorik-Symptomen [4]. Murray und Kolleginnen und Kollegen fassen Monotropismus entsprechend als vereinigende *Linse*, nicht als vollständige Ätiologie [1][14].

Implikation für den Rest dieses Dossiers: Monotropismus ist eine glaubwürdige, zunehmend validierte Ordnungsidee, aber seine *erklärende Reichweite* in jede Komorbidität muss Fall für Fall argumentiert – nicht vorausgesetzt werden.

2. Ebene 1 — Direkte Verbindungen: der neuroentwicklungsbezogene Cluster

2.1 AuDHD und der „monotrope Split“ (stärkste direkte Verbindung)

Autismus und ADHD treten gemeinsam weit häufiger auf, als der Zufall vorhersagen würde: ADHD liegt bei rund **30–80 %** der autistischen Menschen vor, Autismus bei rund **20–50 %** derjenigen mit ADHD [5]; eine Metaanalyse setzt die ASD-Symptomrate in ADHD-Stichproben auf etwa **21 %** [16]; eine große Medicaid-Studie fand, dass **27 %** der autistischen Erwachsenen ohne intellektuelle Beeinträchtigung eine begleitende ADHD-Diagnose hatten – etwa 10× die allgemeine Rate [17]. Die Überschneidung ist zu einem Gutteil genetisch (~50–72 %) [18].

Monotropismus hilft, ein altes Rätsel zu lösen: Wenn Autismus „Hyperfokus“ und ADHD „Aufmerksamkeitsstörung“ ist, warum treten sie gemeinsam auf? Der MQ beantwortet das empirisch – **ADHD-Menschen, besonders AuDHD-Menschen, sind ebenfalls stark monoton** [2][3]. Hyperfokus bei ADHD (Grotewiel et al., 2022) ist konzeptionell nahezu identisch mit dem monotropen Tunnel [19]. Das „monotrope-Split“-Framing fasst AuDHD daher nicht als Gegensätze um, sondern als **ein instabiles System konkurrierender oder schnell wechselnder Aufmerksamkeitstunnel**: Das Gehirn verlangt tiefen monotropen Fokus, kann den Tunnel aber nicht stabilisieren, was die vertraute AuDHD-Oszillation zwischen intensivem Engagement, schnellem Burnout und chronischer Unterstimulation erzeugt [19][20].

Vorbehalt: Der Mechanismus der „multiplen konkurrierenden Tunnel“ ist *plausibel und mit den MQ-Daten vereinbar*, aber als Dynamik noch nicht direkt getestet; er sollte als starke Hypothese gelesen werden.

2.2 Autistisches Burnout und Tunnelstörung

Autistisches Burnout – chronische Erschöpfung, Verlust von Fähigkeiten und verminderte Toleranz – wird zunehmend mit den kumulativen Kosten ständigen Tunnelwechselns, Masking und die Anforderungen übersteigender Kapazität bei unzureichender Erholungs-/Flow-Zeit verknüpft [20][21]. Dies ist ein Bereich, in dem Monotropismus heuristisch mächtig ist (jeder erzwungene Übergang ist ein Tunnelriss),

obwohl die Burnout-Literatur selbst noch reift und der Pfad Monotropismus→Burnout weitgehend klinisch/auf Ich-Perspektive beruht statt experimentell etabliert zu sein [20].

2.3 Vermeidung von Aufforderungen und PDA (*umstrittenes Konstrukt*)

Eine Aufforderung – „Mach dich fertig“, „Füll dieses Formular aus“ – kann als gewaltsamer Einbruch in einen Flow-Zustand erlebt werden. Das ist die intuitive monotrope Erklärung der **Vermeidung von Aufforderungen**. Das spezifischere Konstrukt **Pathological Demand Avoidance (PDA)**, in den 1980ern von Elizabeth Newson geprägt und heute oft als „Pervasive Drive for Autonomy“ umgedeutet, beschreibt ein angstgetriebenes Bedürfnis nach Kontrolle und Vermeidung alltäglicher Aufforderungen [11][22].

Zwei Dinge sind zu trennen:

- **Aufforderungsvermeidendes Verhalten ist real und häufig** bei Autismus, und das monotrope „Tunnelstörungen“-Konzept ist eine vernünftige *mechanistische Erklärung* für die Panik und den Widerstand, die es erzeugt.
- **PDA als eigenes Profil oder Subtyp ist nicht etabliert.** Die britische National Autistic Society stellt fest: „Keine Forschung hat starke Evidenz für [PDA] als eigenes Profil gefunden“ [11]; Newsons grundlegende Studie wurde wegen **zirkulären Schlusses und Überinterpretation** kritisiert (Gruppen, die von den Forschenden definiert wurden, wurden dann „untersucht“) [12][13]; und Übersichten vermerken anhaltende Probleme mit Definition, Konstruktvalidität und Messung [23]. Eine Übersicht von 2023 trägt pointiert den Titel „*Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion*“ [13].

Das Framing des Ausgangstextes ist also halb richtig: Das *Erleben* (eine Aufforderung zersplittert den Tunnel) wird von Monotropismus gut beschrieben; die *diagnostische Entität* (PDA) ist umstritten und sollte nicht als gesichert dargestellt werden.

3. Ebene 2 — Indirekte, über gemeinsame Mechanismen vermittelte Komorbidität

3.1 Anorexie und restriktives Essen

Die Autismus–Anorexie–Überschneidung ist robust und bidirektional: Rund **20–30 %** der Essstörungen-Patientinnen und -Patienten zeigen klinisch bedeutsame autistische Züge, mit den höchsten Raten bei Anorexia nervosa und ARFID [6][24]; umgekehrt haben autistische Erwachsene erhöhte Essstörungen-Raten. Entscheidend: Autistische Züge werden **vor** Essstörungen-Beginn beobachtet, sodass die Überschneidung nicht bloß ein Hungereffekt ist [6].

Die am besten belegte *mechanistische* Brücke ist die **Interozeption** – die Wahrnehmung innerer Körpersignale (Herzschlag, Sättigung). Atypische Interozeption ist in die Ätiologie *sowohl* von Autismus als auch von Essstörungen involviert und „mag zumindest teilweise verantwortlich“ sein für ihre Komorbidität [6]. Dieselbe interozeptive Atypizität liegt der **Alexithymie** zugrunde (Schwierigkeit, Emotionen zu erkennen/zu benennen), die bei ~50 % der autistischen Menschen vorliegt und selbst mit Ess-Pathologie verknüpft ist [7][8].

Wo Monotropismus passt (und wo nicht): Es ist angemessen zu sagen, dass ein monotoner Mensch, der tief in einem Tunnel steckt, Hunger-Signale *verpassen* kann – aber die spezifische Behauptung des Ausgangstextes, „Monotropismus verringert Interozeption“, überzieht die Kausalkette. Die belegte Beziehung lautet **Autismus → atypische Interozeption/Alexithymie → Ess-Vulnerabilität**; Monotropismus ist ein paralleles Merkmal des Autismus, nicht die demonstrierte *Ursache* des interozeptiven Unterschieds [6][7]. Essen/Kalorien-Tracking kann auch selbst zum Tunnel werden, doch das ist mechanismus-plausibel, nicht getestet.

3.2 OCD vs. Hyperfokus: eine echte Unterscheidung

Autismus und OCD treten substantiell gemeinsam auf: ~**17 %** der autistischen Menschen erfüllen OCD-Kriterien vs. ~1–2 % in der Allgemeinbevölkerung [9]. Trotz oberflächlicher Ähnlichkeit (repetitives Verhalten, Rigidität) unterscheidet sich der **affektive Antrieb**, und das ist klinisch gut etabliert:

- **Autistische** eingeschränkte/repetitive Interessen und Routinen sind typischerweise **ego-synton** – angenehm, selbstberuhigend, interessengetrieben, oft regulierend.
- **OCD-Kompulsionen** sind **ego-dyston** – unerwünscht, angstgetrieben, ausgeführt, um befürchtete Folgen zu neutralisieren [9][10].

Die Unterscheidung des Ausgangstextes ist daher korrekt und evidenzgestützt und wird direkt von autistischen Teilnehmenden selbst bestätigt: In einer qualitativen Studie berichteten sie, dass repetitive Verhaltensweisen „Teil davon sind, wer sie sind“, während OCD-Symptome „im Konflikt damit standen, wie sie sich selbst sehen“ [10]. Dieselbe Studie rahmt das gemeinsame Auftreten treffend als „*Autism is the arena and OCD is the lion*“ – OCD-Symptome können autistische Spezialinteressen „entführen“ und deren Intensität und Belastung aufblähen [10]. Monotropismus fügt Kontext hinzu (ein Tunnel kann von OCD-Inhalt *eingefangen* werden), aber die Differenzierung beruht auf der ego-synton/dyston-Achse, nicht auf Monotropismus per se.

3.3 Angst und affektive Störungen (das Substrat unter „Agoraphobie“)

Angst gehört zu den häufigsten Autismus-Komorbiditäten (eine sekundäre Übersicht zitiert ≥ 1 psychiatrische Komorbidität bei ~86 % der autistischen Menschen) [25]. Zwei Mechanismus-Punkte sind für den Verhaltenscluster unten wichtig: (i) **sensorische Überreaktivität** und Angst sind verknüpft und erzeugen über *Kontextkonditionierung* **Vermeidung generalisierter Orte** (Restaurants, Läden, Partys) [26]; (ii) das häufige gemeinsame Auftreten von Alexithymie/interozeptiver Schwierigkeit bedeutet, dass emotionale Zustände oft schlecht benannt sind, was diffuse Angst schürt [7].

4. Ebene 3 — Verhaltens-/funktionaler Cluster: Vermüllung, Horten, Vermeidung, sozialer Rückzug

4.1 Vermüllung, „Doom-Stacks“ und exekutive Dysfunktion

Das *Phänomen* ist gut gestützt: Autistische und ADHD-Menschen zeigen hohe Raten an Desorganisation und Vermüllung, und die am besten belegte Route ist die **exekutive Dysfunktion** – Defizite in Kategorisierung, Entscheidungsfindung, Planung und Arbeitsgedächtnis

[8][27]. Hort-Symptome sind sowohl bei ADHD (mit einer „besonderen Verbindung zur Aufmerksamkeitsstörung“ [8a]) als auch bei Autismus erhöht [8]; bei Autismus zeigt qualitative Arbeit spezifisch, dass die Schwierigkeit des Wegwerfens mit **Interessen-Bindungen und Bedeutung** verknüpft ist, nicht bloß mit Objektwert [28].

Vorbehalt zum Ausgangstext: Die spezifische Behauptung, Vermüllung persistiere wegen eines autistischen „**Objektpermanenz-Defizits**“ („aus den Augen, aus dem Sinn“), ist **nicht durch begutachtete Evidenz gestützt**, die ich ausfindig machen konnte. Objektpermanenz ist bei Autismus typischerweise *intakt oder überlegen*; das Erleben „aus den Augen, aus dem Sinn“ liest sich besser als **Arbeitsgedächtnis-/Aufmerksamkeitsverteilungs-Effekt** (ein getunnelter Geist re-orientiert sich nicht zu gespeicherten Gegenständen) denn als perzeptuales Objektpermanenz-Versagen. Der belegte Mechanismus für Vermüllung bleibt **exekutive Dysfunktion plus Interessen-Bindung**, was die monotrope/AuDHD-Bevölkerung überlappt, aber nicht eindeutig „monotron“ ist [4][8][28].

4.2 Hort-Spektrum-Verhalten

Hort-Störung betrifft ~1,5–6 % der Allgemeinbevölkerung, ist aber bei Autismus erhöht [29]. Bei autistischen Erwachsenen wird hort-artige Wegwerf-Schwierigkeit häufig berichtet, zusammen mit **kognitiven (exekutiven) Schwierigkeiten und starken Interessen-/Bedeutungs-Bindungen** – Gegenstände sind Knoten in einem Netz aus Ideen und künftigem Nutzen, sodass Wegwerfen verlustbehaftet wirkt [28]. Das ist vereinbar mit einem monotropen *Stil* (tiefe Verarbeitung von Objekten), aber wieder ist der belegte Antrieb EF/Bindung, geteilt über neuroentwicklungsbezogene Bedingungen [8].

4.3 Agoraphobie und „Sicherheitsraum“-Eingrenzung (korrekturbedürftig)

Der Ausgangstext rahmt agoraphobisches Haus-Gebundensein als nahezu direktes monotropes Ergebnis. Die Daten sind differenzierter:

- Agoraphobie ist bei Autismus erhöht – ~**23–25 %** der autistischen Erwachsenen (ohne intellektuelle Beeinträchtigung) vs. ~1,3 % in der Allgemeinbevölkerung –, **aber sie ist seltener als soziale Phobie**

oder GAD, und der Effekt konzentriert sich auf die ohne intellektuelle Beeinträchtigung [25].

- Der besser belegte Antrieb ist **sensorische Überreaktivität + soziale Angst** mit kontextkonditionierter Vermeidung überwältigender Orte – d. h., das „Sicherheitsraum“-Verhalten ist real, aber **sekundär gegenüber sensorischer/sozialer Angst**, kein primäres monotropes Phänomen [25][26].

Also: Monotropismus hilft zu erklären, *warum* die Außenwelt störend wirkt (unvorhersehbar, polytrop, tunnelzerstörend), aber die resultierende Eingrenzung als „Agoraphobie“ spezifisch für Monotropismus zu klassifizieren, überzieht die Verbindung. Es ist eine sensorisch-angstgetriebene Vermeidung, die das monotrope Erleben *überlappt*.

4.4 Sozialer Rückzug, „Info-Dumping“ und das Doppelt-Empathie-Problem

Soziale Interaktion ist genuin polytrop – sie verlangt gleichzeitiges Verfolgen von Gesichtern, Tonfall, Hierarchie, Timing und ungeschriebenen Regeln – und ist daher für ein monotropes System unverhältnismäßig kostenintensiv, ein Punkt, der mit Goldknopfs Ressourcenmodell vereinbar ist [4]. Die Intuition des Ausgangstextes ist stichhaltig.

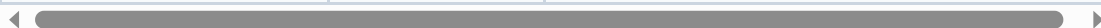
Aber der schärfere, *empirisch gestützte* Rahmen für den resultierenden Kommunikationszusammenbruch ist das **Doppelt-Empathie-Problem** (Milton, 2012; 2017): Die Schwierigkeit ist *bidirektional* und relational – eine „Disjunktion in der Reziprozität zwischen zwei unterschiedlich veranlagten sozialen Akteurinnen und Akteuren“ – kein einseitiges Empathie-Defizit in der autistischen Person [30]. Empirische Arbeit zeigt inzwischen, dass nicht-autistische Beobachterinnen und Beobachter das Doppelt-Empathie-Problem in gemischten Interaktionen *sowohl erkennen als auch selbst zeigen* [31]. „Info-Dumping“ fügt sich natürlich ein: Es ist tiefe suchende Kommunikation aus einem monotropen System, die scheitert, wenn die Gegenseite die Tiefe nicht halten kann – eine Diskrepanz der Verarbeitungsstile, kein Empathiemangel [30][31].

Zu kennzeichnende Lücke: Die DEP-Literatur schließt noch weitgehend autistische Kinder, nicht-sprechende Menschen und Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung aus, sodass die Verallgemeinerung

begrenzt ist [32].

5. Die Grenze: wo das monotrope Konto zu weit greift

Behauptung im Ausgangs-/Laien-Framing	Evidenzstatus	Besseres Framing
Monotropismus <i>verursacht</i> die Merkmale des Autismus	Teilweise gestützt (MQ; Goldknopf)	Ein validierter ordnender Faktor unter mehreren; am stärksten bei sensorischem Autismus [1][4]
AuDHD = „monotroper Split“ (konkurrierende Tunnel)	Stark + direkt messbar (MQ)	Ein reales Aufmerksamkeits-Phänotyp; der dynamische Mechanismus ist hypothesengradig [2][3]
PDA ist ein eigenes Autismus-Profil	Umstritten	Aufforderungsvermeidung ist real; PDA-als-Entität mangelt es an Konstruktvalidität [11][12][13]
Monotropismus <i>verringert</i> <i>Interozeption</i> → Anorexie	Indirekt	Die Brücke lautet Autismus→Interozeption/Alexithymie→Ess-Vulnerabilität; Monotropismus ist parallel, nicht die gezeigte Ursache [6][7]
Vermüllung durch ein „Objektpermanenz-Defizit“	Ungestützt	Exekutive Dysfunktion + Interessen-Bindung; kein perzeptuales Objektpermanenz-Defizit belegt [4][8][28]
Agoraphobie als primäres monotropes Ergebnis	Überzogen	Sekundär gegenüber sensorischer Überreaktivität + sozialer Angst; seltener als GAD/soziale Phobie [25][26]
OCD vs. monotrope „Zwangsvorstellungen“ unterscheiden sich im Affekt	Gut gestützt	Ego-dyston (OCD) vs. ego-synton (autistisches Interesse); OCD kann Tunnel „entführen“ [9][10]
Doppelt-Empathie-Problem erklärt sozialen Zusammenbruch	Gestützt (aber Lücken)	Bidirektionale Diskrepanz; Stichproben tendieren zu sprechenden Erwachsenen ohne intellektuelle Beeinträchtigung [30][31][32]



6. Offene Fragen

1. **Dynamisches Testen des Tunnels.** Der MQ ist ein *Trait*-Maß. Ist der „monotrope Split“ (konkurrierende/instabile Tunnel bei AuDHD) in Echtzeit-Aufmerksamkeit/EEG beobachtbar? Weitgehend ungetestet.
2. **Kausalpfeil zur Interozeption.** Erzeugt eine monotrope Ressourcenverteilung interozeptive Atypizität, oder teilen sie eine gemeinsame vorgelagerte Ursache? Die aktuelle Evidenz kann diese nicht trennen [6][7].
3. **PDA-Klärung.** Wird die Forschung zur Aufforderungsvermeidung auf ein validiertes, messbares Konstrukt konvergieren oder eine umstrittene Laien-/Klinikkategorie bleiben? [11][13]
4. **Vermüllungs-Mechanismus.** Ist „aus den Augen, aus dem Sinn“ ein Arbeitsgedächtnis-/Verteilungseffekt (plausibel) oder etwas anderes? Keine dedizierte Studie gefunden.
5. **DEP-Verallgemeinerbarkeit.** Wie wirkt das Doppelt-Empathie-Problem bei nicht-sprechenden autistischen Menschen, Kindern und Menschen mit begleitender intellektueller Beeinträchtigung? [32]
6. **Burnout.** Was ist der spezifische, testbare Beitrag des monotropen Tunnelrisses zum autistischen Burnout gegenüber Masking, Trauma und chronischer Anforderung? [20]

Quellen

- [1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism. *Autism*.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1362361305051398> [2]
Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A., & Fletcher-Watson, S. (2023). The Monotropism Questionnaire (MQ). Open Science Foundation (Preprint). Kommentar/Zusammenfassung:
<https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-and-the-monotropism-questionnaire> ; Spiegel: <https://stimpunks.org/monotropism-questionnaire> [3] Autistic Realms / Neurodiverse Connection (Edgar) — Zusammenfassung der MQ-Befunde (47 Items; N=1.110; autistisch + ADHD scoren signifikant höher):
<https://autisticrealms.com/monotropism-vs-polytropism-adhd-audhd-autistic-attention> [4] Goldknopf, E. J. (2013). Atypical resource allocation

may contribute to many aspects of autism. *Frontiers in Integrative Neuroscience*. PMC3872719.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3872719> [5] Psych Scene Hub — Review zur ADHD-und-Autismus-Komorbidität (ADHD bei ~30–80 % von ASD; ASD bei ~20–50 % von ADHD; zitiert Lau-Zhu 2019; Hollingdale 2019): <https://psychscenehub.com/psychinsights/adhd-and-autism-comorbidity-a-comprehensive-review> [6] Adams, K. L., Murphy, J., Catmur, C., & Bird, G. (2022). The role of interoception in the overlap between eating disorders and autism: methodological considerations. *European Eating Disorders Review*. PMC9543236.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9543236> [7] Klein, M., Witthöft, M., & Jungmann, S. M. (2025). Interoception in individuals with autism spectrum disorder: a systematic literature review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry* (10.3389/fpsyt.2025.1573263) — ~50 % der autistischen Menschen haben Alexithymie, vermittelt über interozeptive Defizite.

<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2025.1573263/full> [8] Morein-Zamir, S., Kasese, M., Chamberlain, S. R., & Trachtenberg, M. (2020). Elevated levels of hoarding in ADHD: a special link with inattention. *Journal of Psychiatric Research*. PMC7612156.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7612156> — [8a] die „besondere Verbindung zur Aufmerksamkeitsstörung“ ist der eigene Untertitel des Papiers. Siehe auch Drake Institute zu ADHD/exekutiver Dysfunktion:

<https://drakeinstitute.com/articles/adhd/adhd-and-executive-dysfunction-connection> [9] Animosanopsychiatry — systematisches-Review-Summary: ~17 % der autistischen Menschen erfüllen OCD-Kriterien vs. ~1–2 % Allgemeinbevölkerung; ego-synton vs. ego-dyston

Unterscheidung: <https://animosanopsychiatry.com/blog/ocd-vs-autism-similarities-differences-and-overlaps> [10] Long, H., Cooper, K., & Russell, A. (2024). „Autism is the arena and OCD is the lion”: autistic adults' experiences of co-occurring OCD and restricted/repetitive behaviours (qualitativ). PMC11497754.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497754> [11] National Autistic Society — Demand avoidance („keine Forschung hat starke Evidenz für [PDA] als eigenes Profil gefunden“): <https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/behaviour/demand-avoidance> [12] Frontiers in Education (2024). Methods of studying PDA — Kritik an Newsons zirkulärem

Schluss (Green et al. 2018; O'Nions & Eaton 2020):

<https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2024.1230011/full> [13] Kildahl, A., et al. (2023). Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion. PubMed 36892327. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36892327> [14] Murray, F. (Lawson) (2018). Me and Monotropism: a unified theory of autism. *The Psychologist* (BPS). <https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism> [15] Happé, F., & Frith, U. (2006). The weak coherence account: detail-focused cognitive style in ASD. *J Autism Dev Disord* 36:5–25 (zitiert über eine vergleichende Frontiers-2024-Studie): <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1348074/full> [16] Hollingdale, J., et al. (2019). Metaanalytisches Review zu ASD-Symptomen bei ADHD (zitiert über Psych Scene Hub und Autistica): <https://www.autistica.org.uk/what-is-autism/adhd-and-autism> [17] Children's Hospital of Philadelphia — 27 % der autistischen Erwachsenen ohne intellektuelle Beeinträchtigung hatten begleitende ADHD (~10× Allgemeinbevölkerung): <https://www.chop.edu/news/rates-adhd-remain-high-adulthood-among-patients-autism> [18] Behavioral Innovations — Zusammenfassung zur genetischen Überlappung (~50–72 %): <https://behavioral-innovations.com/blog/the-sudden-rise-of-adhd> [19] Autistic Scholar — „Revisiting monotropism“ (AuDHD als konkurrierende Tunnel; verweist auf Grotewiel et al. 2022 zu ADHD-Hyperfokus): <https://www.autisticscholar.com/monotropism> [20] Neurodiverse Connection (Edgar) — Monotropism, young people and autistic burnout: <https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-young-people> ; Autistic Realms — Reclaiming rest: <https://autisticrealms.com/reclaiming-rest-autistic-burnout-monotropism-and-resistance> [21] National Autistic Society — What is monotropism? (Flow-Zustände; verweist auf Heasman et al. 2024 „autistic flow theory“): <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism> [22] PDA North America — What is PDA? (Newson, 1980er; „Pervasive Drive for Autonomy“-Umdeutung): <https://pdanorthamerica.org/what-is-pda> [23] O'Nions, V., et al. (2016). Identifying features of PDA using the DISCO. PMC4820467. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4820467> [24] Nickel, K., Maier, S., Endres, D., & Joos, A. (2019). Systematic Review: Overlap Between Eating, Autism Spectrum, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Frontiers in Psychiatry*. PMC6796791 (zitiert auch Westwood, Mandy &

Tchanturia 2017; Huke et al. 2013).

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6796791> [25] Discussing Psychology (Loker) — Agoraphobie bei Autismus ~23–25 % (ohne intellektuelle Beeinträchtigung) vs. ~1,3 % Allgemeinbevölkerung; seltener als soziale Phobie/GAD (Sekundärquelle, stützt sich auf Helles et al. 2020 und Lugnegård et al. 2012):

<https://www.discussingpsychology.com/agoraphobia-and-autism-are-they-intrinsically-linked> [26] Green, S. A., & Ben-Sasson, A. (2010).

Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with ASD: is there a causal relationship? *Journal of Autism and Developmental Disorders* — Kontextkonditionierung und Vermeidung. PMC2980623.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2980623> [27] Embrace Autism — Autism and hoarding (exekutive Funktion, Entscheidungsfindung):

<https://embrace-autism.com/autism-and-hoarding> [28] Goldfarb, Y., Zafrani, O., Hedley, D., & Yaari, M. (2021). Autistic adults' subjective experiences of hoarding and self-injurious behaviors (qualitativ). *Autism*. PMC8264636. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8264636> [29]

Abouzed, M., Gabr, A., Elag, K. A., Soliman, M., Elsaadouni, N., Elzahab, N. A., & Barakat, M. (2024). The prevalence, correlates, and clinical implications of hoarding behaviors in high-functioning autism. *Scientific Reports* (s41598-024-75371-8). <https://www.nature.com/articles/s41598-024-75371-8> [30] Milton, D. (2012). On the ontological status of autism: the 'double empathy problem'. *Disability & Society* 27(6):883–887; Milton (2017) Erweiterung. Zusammenfassung:

<https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/double-empathy> [31] Jones, D. R., Botha, M., Ackerman, R. A., & King, K. (2024). Non-autistic observers both detect and demonstrate the double empathy problem when evaluating interactions between autistic and non-autistic adults. *Autism*. PMC11308351.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11308351> [32] Wikipedia — Double empathy problem (anerkannte Forschungslücken: Kinder, nicht-sprechend, intellektuelle Beeinträchtigung):

https://en.wikipedia.org/wiki/Double_empathy_problem

Hinweis zu den Evidenzebenen: Ebene 1 = direkte, replizierte Messung (MQ; AuDHD-Raten); Ebene 2 = replizierte Komorbidität mit einer belegten gemeinsamen Mechanismus; Ebene 3 = plausible Extrapolation, Einzelquelle oder umstrittenes Konstrukt. Siehe §5.